ENDOMETRIÓZIS
MAGYARORSZÁG

Endometriózis kisokos

TARTALOMJEGYZÉK:

Köszöntő 1
Endometriózisról 2
Adenomiózisról 8
Gyógyszeres kezelési lehetőségekről 11
Endometriózis és Meddőség 1
Endometriózis műtéti megoldásai 2
Orvos-páciens kommunikáció 25
Enzian 2
Gyakran ismételt kérdések 28
Irodalomjegyzék 39

Kiadó: „Együtt Könnyebb" Női Egészségért Alapítvány, Budapest, 2025
Grafika: Mensáros Dóra (Barna Design Kft.)
Lektorálta: Dr. Bokor Attila (PhD, MSc Egyetemi docens, az Európai Endometriosis Liga (EEL) alelnöke, a Magyar Nőgyógyászok Endoszkópos Társaságának (MNET) Elnöke)
Nyomda: Pauker Holding Kft.

Kedves Olvasó!



Salamon Adrienn
„Együtt könnyebb" Női Egészségért Alapítvány, kuratórium elnöke
Endometriosis Society vezetőségi tag

Az endometriózissal való együttélés sokszor bizony egyáltalán nem könnyű a mindennapokban. A diagnosztizálást követően, a kezdeti „mindent tudni szeretnénk a betegségről" korszak után jön a felismerés, hogy miről is szól valójában az endometriózis kihívás, és elindulunk a gyógyuláshoz vezető úton. Ezen az úton rengeteg kérdés merül fel bennünk, vannak nehézségek, fájdalmak és hullámvölgyek, ugyanakkor új barátságok alakulnak ki, és sok öröm is ér bennünket. Magyarországon több mint 200.000 nő küzd endometriózissal, és a statisztikák szerint azok közül, akik fájdalmas menstruációval küzdenek, minden második nőnek endometriózisa van! Hogy miért hangsúlyozzuk ezeket a számokat itt is? Azért, hogy tudatosítsd magadban, hogy NEM VAGY EGYEDÜL! Nem kell, hogy magadba zárkózz, nincs szégyellnivalód és nincs olyan kérdés, amit ne tehetnél fel, ugyanis nincs rossz kérdés!

2009 óta előadásokkal, klubnapokkal, cikkekkel igyekszünk tájékoztatni a hölgyeket az endometriózisról, segítséget nyújtunk annak érdekében, hogy mielőbb megfelelő, szakértő orvosokhoz kerüljenek, és törekszünk arra, hogy a felmerülő tévhiteket eloszlassuk. A munkánk során endometriózis centrumokkal, nőgyógyászokkal és kiegészítő, alternatív terápiával foglalkozó szakértőkkel dolgozunk együtt, és támogatjuk egymás munkáját annak érdekében, hogy mielőbb megszűnjenek a tüneteid, a fájdalmaid, és egy minőségi életet élhess. Ez az Endometriózis Kisokos azért született meg, hogy ezzel is segítsünk Téged az utadon. Az összeállításában olyan nőgyógyászok vettek részt, akik nap mint nap harcolnak korunk titokzatos betegsége, az endometriózis ellen.

Endometriózis



Dr. Csibi Noémi

szülés-nőgyógyász, egyetemi tanársegéd

Az endometriózis a termékeny korú nők körülbelül 10-15%-át érintő krónikus, jóindulatú betegség, amely méhnyálkahártyához hasonló szövet megjelenését és szaporodását jelenti a méh üregén kívül, leggyakrabban a kismedencében, a petefészkekben, illetve a hashártya felszínén.

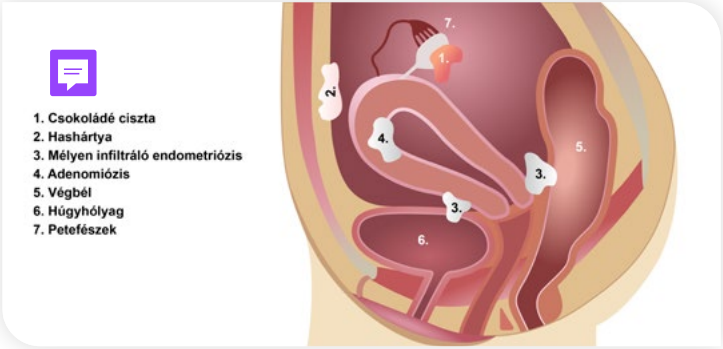
Abban az esetben, ha az endometriózis nemcsak a szervek felszínén helyezkedik el, hanem azok falába is betör, mélyen infiltráló endometriózisról beszélünk, mely érintheti a hüvely és a végbél közötti területet, a vastag-, vég-, illetve ritkábban a vékonybelet; a húgyhólyagot és a húgyvezetéket.

Kialakulása

A betegség kialakulásának pontos oka nem ismert. A széles körben ismert elmélet szerint a legtöbb nőnél előforduló retrográd menstruáció (a menstruációs folyadék fordított irányú, hasüreg felé történő távozás) fájdalmas nőkben hozzájárulhat az endometriózis kialakulásához. Ugyanakkor ezentúl számos – a betegség kialakulásának mechanizmusát magyarázó – elmélet olvasható az irodalomban. Valószínű, hogy mind veleszületett (genetikai) faktorok, mind környezeti tényezők együttes hatása szükséges a betegség kialakulásához.

Tünetek

Az endometriózis szigetek összhangban állnak a menstruációs ciklus hormonváltozásaival, mely magyarázza, hogy a panaszok a menstruáció ideje alatt rendszerint fokozódnak. Egyes tünetek így ciklussal összefüggőek, míg mások attól függetlenek. A tünetek továbbá lehetnek nőgyógyászati elhelyezkedésűek és egyéb szervrendszereket érintők is:



Forrás: https://www.mdpi.com/ijms/ijms-21-02815/article_deploy/html/images/ijms-21-02815-g001.png

- a leggyakoribb tünet a fájdalmas menstruáció
- jellemző lehet a vizelet-, illetve székletürítést kísérő fájdalom *(súlyos esetben véres vizelet, illetve véres széklet),*
- valamint a szexuális élet kapcsán vagy azt követően fellépő mély hasi fájdalom.
- a betegség jelenléte különböző emésztőszervrendszeri tünetek megjeléséhez is vezethet, mint haspuffadás, székrekedés vagy hasmenés, fájdalmas bélmozgások
- emellett a betegség gyakran társul krónikus, ciklustól független kismedencei fájdalommal
- ritkábban vállcsúcsba sugárzó fájdalommal
- ritkán ciklikus köhögéssel, vérköpéssel, mellkasi fájdalommal
- ciklikus hegduzzanattal és fájdalommal.

Ismert, hogy a fájdalom intenzitása és a betegség kiterjedése között nincs szoros összefüggés: egyes esetekben enyhe betegség is igen kifejezett panaszokat okozhat, míg más esetekben súlyos megjelenési formák is lehetnek panaszmentesek. Utóbbi esetben gyakran az egyetlen figyelemfelhívó tünet a meddőség lehet, mely az endometriózisban érintettekben körülbelül 30-40%-ban fordul elő.

Kivizsgálás

1. Endometriózis irányú kivizsgálás első lépéseként fontos a gondos, részletes kórelőzmény felvétel, valamint a panaszok részletes leírása.

TIPP: *javasoljuk a LUCY applikáció napi használatát már az első menstruációtól kezdve. Az applikáció összesítőjét mutasd meg az orvosodnak, ezzel segítheted, hogy minél korábban kapj diagnózist.*

2. Ezt követően nőgyógyászati vizsgálat és képalkotó vizsgálat elvégzése javasolt: rutinszerűen hüvelyi ultrahang vizsgálat, valamint válogatott esetekben kismedencei MRI vizsgálat végezhető.

FIGYELEM! *Előfordulhat, hogy a fenti kivizsgálás nem vezet eredményre, egyes endometriózis megjelenési formák ugyanis képalkotó vizsgálattal nem ábrázolhatók. A panaszok változatos intenzitása és a képalkotó eljárások korlátozott értéke miatt a diagnózis felállítása sok esetben nehéz és időigényes, az első tünetek jelentkezése és az endometriózis igazolása között Közép-Európában 4-10 év telik el. Magyarországon a diagnosztikai késedelem 4 év.*

3. Az endometriózis végleges diagnózisát jelenleg (laparoszkópos) műtét által lehet megerősíteni akkor, ha a képalkotó eljárások nem vezettek eredményre (ESHRE 2022).

Rekeszizmot érintő endometriózis



Dr. Bokor Attila

Egyetemi docens, Európai Endometriosis Liga (EEL) alelnöke

A rekeszizom szövetében felhalmozódó, méhnyálkahártyához hasonló szövet ugyanúgy reagál a menstruációs ciklus hormonjaira, mint a szabályos helyen lévő, méh üregén belül elhelyezkedő endometrium. A rekeszt érintő endometriosis az összes eset mindössze 1,5%-át teszi ki, vagyis sokkal ritkább, mint a kórkép egyéb formái, melyek jellemzően a petefészkeket és más kismedencei szerveket érintenek. Rekeszelváltozás esetén gyakran a kismedencei szervek érintettségével is számolni kell.

Tünetek

A kórkép egyéb formáihoz hasonlóan előfordul, hogy a rekeszizom-endometriózis nem okoz tüneteket az érintett pácienseknek, azonban a menzesz idején jelentkező mellkasi-, felhasi-, váll- és karfájdalom felvetheti a betegség gyanúját. A tünetek gyakran mély légvétellel, köhögéssel összefüggenek. Ritka, azonban súlyos szövődmény lehet a rekeszizom betegség által történő átfúródása, amely az érintett oldali tüdőfél összeesését okozhatja.

Diagnózis

A rekeszizom-érintettség gyanúját a tüneteken túl, MRI vizsgálat vetheti fel, azonban biztos diagnózis csak laparoszkópos műtét végzése során állítható fel.

Kezelés

A kórkép terápiája leggyakrabban laparoszkópos/ lézer-laparoszkópos beavatkozás (melynek során eltávolítható a hasüreg egyéb területein elhelyezkedő endometriózis is), valamint hormonális kezelést foglal magában.

Keresztcsonti, obturátor, valamint ülőidegeket érintő endometriózis



Dr. Bokor Attila

Egyetemi docens, Európai Endometriosis Liga (EEL) alelnöke

Kismedencei ideg-érintettségről beszélünk, ha mélyen infiltráló endometriózis csomók által okozott, idegek ellátási területének megfelelő, nyomási tünetek megjelenését tapasztaljuk.

Tünetek

Ezeken a speciális helyeken elhelyezkedő csomók esetén a páciensek a far- vagy láb zsibbadását, medencébe, hátba, lábakba, lábfejbe sugárzó fájdalmat, lábizmok gyengeségét, járási nehezítettséget, vizelési- és székelési fájdalmat, székrekedést tapasztalhatnak.

Ezen felül az érinett idegek ún. dermatómáinak megfelelően jelentkezhetnek az említett eltérések. A porckorongsérveknél tapasztalt, hasonló lefutású fájdalomtól megkülönböztetheti, hogy az ülőideg endometriózisában a comb elülső oldala leggyakrabban fájdalommentes marad. Az endometriózis által okozott hasi fájdalomhoz hasonlóan a fájdalom - legalábbis a betegség kezdetén - főként a menstruációs ciklus során jelentkezik, azonban gyakran kezelés nélkül a csomók növekedésükkel folyamatos kompressziót okozva, a fájdalom előbb-utóbb tartósan megmarad, és a menstruáció alatt erősödést mutat.

Diagnózis

Az ideg-endometriózis gyanúját a tüneteken túl hüvelyi ultrahang, valamint MRI vizsgálat vetheti fel, biztos diagnózis azonban csak laparoszkópos műtét végzése során állítható fel.

Kezelés

Tekintettel arra, hogy a mélyen infiltráló csomók kezelés nélkül növekedésükkel súlyos neurológiai tüneteket okozhatnak, a kórkép terápiáját, a hormonális kezelés sikertelensége esetén a műtéti beavatkozás jelenti. Mivel az idegek érintettségével járó mélyen infiltráló endometriózis sebészi kezelése ideg-károsodás kockázatával járhat, ez szenzoros vagy motoros károsodáshoz, vizelet-, székletürítési vagy szexuális funkció zavarhoz vezethet, ezért ezen műtétek elvégzése a kórképre szakosodott centrumokban javasolt.

Adenomiózis



Dr. Bokor Attila

Egyetemi docens,
Európai Endometriosis
Liga (EEL) alelnöke

Az adenomiózis egy jóindulatú, ösztrogén-függő nőgyógyászati betegség, mely esetében méhnyálkahártya sejtek (mirigysejtek és kötőszövet) terjednek a méhizomzat sejtjei közé, így a méhizomzat megvastagodását okozva.

Kialakulása, előfordulása

Az adenomiózis kialakulásának oka nem ismert, számos teória látott napvilágot, azonban a leginkább elfogadott elmélet szerint, a méhben a méhizomzat, és a méhnyálkahártya legmélyebb rétege közötti határfelületi zavar miatt a méhnyálkahártya nem megfelelő méhizomzatba terjedése, érképződés és méhizomzat sejtjeinek számbeli és térfogatbeli növekedése alakul ki.

Az adenomiózis előfordulásának gyakorisága nehezen meghatározható, 5-70% közötti a nemzetközi irodalom szerint, a különböző diagnosztikus kritériumoktól függően. Az estek 60%-ában endometriózissal társul. Az adenomiózis több formában is előfordulhat, érintheti az egész méhizomzatot, ebben az esetben diffúz adenomiózisról beszélünk, míg fokális betegség esetén az elváltozás gócokat képez a méhizomzaton belül.

Tünetek

Az adenomiózis számos panaszt okozhat, mint a rendellenes méhvérzés (erős és/vagy elhúzódó menstruáció, menstruációk közötti vérzés, menstruáció előtti pecsételő vérzés), kismedencében jelentkező fájdalom (fájdalmas menstruáció, fájdalmas szexuális együttlét), krónikus kismedencei fájdalom, meddőség, helyi nyomási tünetek, húgyúti és bélrendszeri tünetek (fájdalmas vizelet- vagy székletürítés). Azonban a páciensek körülbelül egyharmada teljesen tünetmentes.

Diagnózis

Az adenomiózis előfordulásának, és súlyosságának megítélése igen nehézkes. A végleges diagnózis felállítása szövettani vizsgálattal lehetséges. A nemzetközi irodalom szerint korábbiakban a rendellenes méhvérzés, illetve menstruációs fájdalmak miatt, többször szült, méheltávolításon átesett nők szövettani vizsgálata kapcsán igazolódott adenomiózis. Azonban friss közlemények bizonyítják, hogy adenomiózis fiatal, nem szült nők esetében is igen magas számban fordul elő.

Az adenomiózis diagnózisának felállításában segítségünkre lehetnek képalkotó vizsgálatok, mint a nőgyógyászati hüvelyi ultrahang vizsgálat és az MRI vizsgálat. Tekintettel az MRI vizsgálat magasabb költségére, és a nőgyógyászati ultrahang könnyebb elérhetőségére, az ultrahang az elsőként választandó diagnosztikus eszközünk a kórkép meghatározásában. Nőgyógyászati fizikális vizsgálat kapcsán puhább, kerekded, megnagyobbodott méhet tapinthat az orvos.

Kezelése

1. Gyógyszeres kezelés

Az adenomiózis gyógyszeres kezelése megegyezik az endometriózis gyógyszeres kezelési lehetőségeivel. Befejezett családtervezés esetén, amennyiben a páciensnek nincs további gyermekvállalási szándéka, és a gyógyszeres kezeléssel a panaszok nem csökkenthetők, méheltávolítás lehetősége is felmerül. Az adenomiózis gyakran egyéb nőgyógyászati betegségekkel együtt fordul elő, az esetek 50%-ban mióma és 7%-ban méhnyálkahártya polyp is jelen lehet.

Számos tanulmány bizonyítja, hogy adenomiózis esetében bizonyos szülészeti kórképek előfordulásának esélye is emelkedett, mint a terhességgel összefüggő magasvérnyomás betegségek, a magzat méhen belüli súlyfejlődési elmaradása, a vajúdás folyamatának elakadása, méhlepény rendellenességek.

2. Sebészeti kezelése

A sebészi kezelés lehet hiszteroszkótos (méhtükrözéses) vagy hasmetszés illetve hastükrözés útján történő. A kisméretű noduláris formák eltávolítása megkísérelhető, azonban a súlyos diffúz adenomyosis sebészi kezelése körül számos ellentmondás van. A legszélesebb körben a kettő vagy több lebenytechnika akalmazásával végzett Osada-műtét terjedt el, azonban ennek az alkalmazhatósági köre is vitatott. A radiofrekvenciás terápiák megoldást jelenthetnek a jövőben.

Gyógyszeres kezelési lehetőségekről



dr. Brubel Réka
Szülész-nőgyógyász,
Egyetemi tanársegéd

A gyógyszeres kezelés nélkülözhetetlen a tüneti kezelésben és az endometriotikus elváltozások újbóli kialakulásának megakadályozásában.

Műtét előtti lehetőségek

A laparoszkópos beavatkozás előtt lehetséges a betegség okozta fájdalom csökkentése nem-szteroid gyulladásgátlóval vagy hormonális terápiával (fogamzásgátló tablettákkal, csak sárgatesthormont tartalmazó készítményekkel vagy GnRH agonistákkal, -antagonistákkal).

Műtét utáni lehetőségek

A műtétet követően többféle gyógyszeres kezelési lehetőség áll rendelkezésre. A gyógyszeres terápia megválasztása mindig a beteg gyermekvállalási szándékától függ. Célja minden esetben a betegség kiújulásának megelőzése, valamint a műtét során el nem távolított mikroszkopikus endometrióziszos elváltozások növekedésének megakadályozása.

- Amennyiben a betegnek aktív gyermekvállalási terve van, és a műtétet követően spontán teherbeesésre van lehetőség, a gyógyszeres terápia nem indokolt.
- Aktív gyermekvállalási terv és a spontán teherbeesés lehetőségének hiánya esetén in vitro fertilizációs (IVF), vagyis lombikbébi-kezelés javasolható.
- Abban az esetben, ha gyermekvállalási terv nem áll fenn, ovárium szuppressziós kezelést javaslunk. Ez a petefészek-működésének leállítását szolgálja, mivel így az endometrióziszsövetek növekedése is leáll az esetek nagy részében. Mivel a meddőség kialakulása annál valószínűbb, minél tovább van jelen a betegség, ezért ajánljuk a mielőbbi gyermekvállalást.

1. Kezelést megelőzően a diagnózishoz már nem kell műtét!

A beavatkozás előtt az első lépés az endometriózis okozta legfőbb tünet, vagyis a fájdalom kezelése. Az endometriózis okozta fájdalom megjelenési formái a fájdalmas menzesz, a fájdalmas szexuális élet, a fájdalmas vizeletürítés, a fájdalmas székletürítés és a ciklustól független alhasi fájdalom. Ezek kezelésére nem-szteroid gyulladáscsökkentők (*NSAID, Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs*) és/vagy hormonális terápia alkalmazható. A mindennapi gyakorlatban a nem-szteroid gyulladáscsökkentők közül legygyakrabban *ibuprofen-*, *nimesulid-* vagy *naproxentartalmú* tablettát ajánlunk betegeinknek. Az NSAID-ok mellett a hormonális terápia (*orális fogamzásgátlók, csak sárgatesthormont tartalmazó készítmények vagy GnRH agonisták, -antagonisták*) alkalmazása is jelentősen csökkenti az endometriózis okozta fájdalmat. A két gyógyszeres terápia párhuzamos alkalmazása is lehetséges a tünetek csökkentése érdekében.

2. Gyógyszeres kezelés műtét után, meddőség esetén IVF-kezelés (lombikbébi-kezelés) javallatával

Abban az esetben, ha meddőségi kivizsgálás keretein belül történik a laparoszkópos beavatkozás, és endometriózis okozta lezárt petevezetékeket diagnosztizálunk, a megtermékenyülés csak IVF-, vagyis lombikbébi-kezelés segítségével történhet.

3. Terápia a diagnózis felállítása után gyermekvállalási szándék hiányában

Ha a betegnél a műtétet követően nem áll fenn gyermekvállalási szándék, különböző gyógyszeres kezelésekre van lehetőség. Abban az esetben, ha a beteg még nem szült, kombinált orális fogamzásgátló tabletta (OAC) folyamatos szedése javasolt. Az OAC megfelelő megválasztásánál figyelembe kell venni a szer hormonösszetételét. Ajánlott gesztagén túlsúlyos vagy „progestine-only" tablettát alkalmazni. Az OAC ciklus nélküli, folyamatos szedése a menstruáció megszűnéséhez és így a tünetek csökkenéséhez vezet. Ha a beteg anamnézisében már szerepel szülés, hormonkibocsátó (gesztagén)

méhen belüli eszközt helyezhetünk fel, leggyakrabban a levonorgestreltartalmú méhen belüli gyógyszerleadó rendszert (LNG-IUS). Újabban kisebb méretű LNG-IUS nem szült nők esetében is javasolható.

Az endometriózis okozta panaszok enyhíthetőek *dienogeszt* terápiával is Napi 1 tabletta 2 mg dienogeszt alkalmazása jelentősen csökkenti az endometriózisos elváltozások méretét, a fájdalmat és összességében javítja az életminőséget. Lehetséges mellékhatásai a pecsételő vérzés és az elhízás, ami a betegek kevesebb mint 10%-ánál jelentkezik, de a gyógyszer hosszú távú alkalmazása esetén ezek a nemkívánt hatások elmúlnak. A betegek kevesebb, mint 1%-ánál figyelhetünk meg hüvelyszárazságot. Vizsgálatok folynak a dienogeszt hosszú távú alkalmazásáról.

A fent felsoroltak nem megfelelő mértékű hatékonysága esetén GnRH antagonista terápia hozhat enyhülést, amely napi egy tablettában tartalmazza a petefészkek működését gátló hatóanyagot és egy kis mennyiségű ösztrogént, illetve sárgatesthormont, hogy megelőzze a menopauzás tüneteket. Ennek a kiegészítésnek köszönhetően a készítmény hosszú távon alkalmazható.

Amennyiben képalkotó eljárásokkal nem igazolható endometriózis jelenléte, úgy a diagnosztikus laparoscopia a választandó lépés panaszos betegek esetében.

Endometriózis és meddőség



Dr. Fülöp István
Nőgyógyász Főorvos
Meddőségi és Endoszkópos Specialista

Mint az közismert, az endometriózisban szenvedő nők életét leginkább befolyásoló tünetek a különböző megjelenésű alhasi és hasi fájdalmak, valamint a termékenységi képesség csökkenése. A női eredetű meddőség hátterében kb. 30%-ban lehet endometriózist igazolni.

1 évnél hosszabb, aktív házasélet melletti sikertelen teherbeesési próbálkozás után a párnak érdemes meddőségi központot felkeresni a terhesség kialakulását gátló tényezők felderítése és kezelése céljából. A kivizsgálás során feltárt problémák kezelésének megoldására, felkészült reprodukciós munkacsoport által készített komplex terápiás terv felállítása és annak kivitelezése vezethet a várva-várt gyermekáldás létrejöttéhez.

A korszerű meddőségi problémamegoldás során nagy jelentősége van az alapos kivizsgálásnak, mely során MINDIG gondolnunk kell a női eredetű meddőség 30%-áért felelős endometriózis fennállásának lehetőségére. A precíz oknyomozásnak nemcsak a szakorvosi vizsgálat és az ultrahang a része, hanem a körültekintő kórelőzményi kikérdezés is, melynek eredményeképpen nem szabad figyelmen kívül hagynunk, ha a tipikus endometriózis tünetek közül egy, vagy több is jelen van az érintett hölgy mindennapjaiban. A részletes meddőségi kivizsgálás során végzett képalkotó eljárások (UH, MRI) és az endometriózis kezelésben is jártas meddőségi szakember nagyban segítheti a minél korábbi diagnózis felállítást, mely elősegíti az optimális eredmény mielőbbi elérését.

A legújabb 2022-es ESHRE (Europian Society of Human Reproduction and Embryology) iránymutatás szerint már nem kell feltétlenül laparoszkópiát végeznünk ahhoz, hogy az endometriózis diagnózisát felállítsuk, viszont szükség van szakmailag jól felkészült reprodukciós szakemberek jelenlétére.

A kismedencében fennálló endometriózis érintheti mind a belső nemi szerveket, a méhet, petefészkeket, petevezetékeket, mind a környező extragenitális szerveket, a hashártyát, a beleket, húgyhólyagot, húgyvezetéket. Tudjuk, hogy nem minden endometriózisos állapotot kell megoperálni, de a precíz kivizsgálás elengedhetetlen feltétele az ideális terápiás terv kialakításának.

Az endometriózis oly módon okozhat termékenységi képesség csökkenést, hogy amikor a kismedencében jelen van, akkor a havi ciklusosságot figyelembe véve válik aktívabb és kevésbé aktív állapotú szövetté. Az aktív időszakban olyan gyulladásos faktorokat tartalmazó izzadmányt bocsát ki magából, ami folyadék filmréteggel vonja be a kismedence szerveit és okoz bennük funkciózavart. A méhnek rontja azon pulzatilis mozgását, mely elősegíti a teherbe esést, a petevezetéknek rontja a transzport funkcióját, mely segíti a spermiumok méhből kifelé jutását és a zigóta méh felé haladását.

A petevezetékből kijutó spermiumok vitalitása és így termékenyítőképessége gyengül. A petefészekből kiszabaduló petesejtek genetikai szerkezeti minősége szintén romlik. Ismert, hogy az endometriózis összenövéseket is kialakíthat, mely miatt elzáródhatnak a petevezetékek és létrejöhetnek olyan mélyen infiltráló hegesedések, melyek fájdalmas szexuális élethez vezethetnek, ami szintén negatív hatással vannak a teherbe esésre.

Ezen információk birtokában felmerülhet a kérdés, hogy akkor miért nem operálunk meg minden endometriózis esetet?

A reprodukciós sebészettel foglalkozó szakemberek feladata az, hogy eldöntsék a műtét szükségességét, vagy szükségtelenségét. Szakmailag nem minden endometriózis állapotot indokolt megoperálni. Azonban, ha műtétre van szükség, akkor fontos a műtét minősége. Az érintett páciens későbbi életminőségét és endometriózis kiújulási hajlamát nagyban befolyásolja az első műtét sikeressége. A kismedencében jelen lévő endometriózis elváltozások radikális kiirtása javítja a teherbe esési esélyeket, ezért a meddő nők kezelését jól felkészült komplex munkacsoportnak kell végeznie.

Ha felállítottuk az endometriózis és a meddőség diagnózisát, és nem műtét mellett döntünk, akkor ki kell alakítanunk a legideálisabb konzervatív kezelési javaslatot páciensünk számára. Ebben nagy segítséget jelenthet a szakemberek számára a legújabb tudományos eredményeket figyelembe vevő fentebb már említett 2022-es ESHRE iránymutatás és a 2023-ban megjelent hazai szakmai irányelv.

Ennek szellemében a korábban sokat emlegetett és sok nő életminőségét megrontó, rengeteg mellékhatással bíró GnRH agonista gyógyszerek hosszú távú adagolása már nem tekinthető korszerűnek és ajánlottnak meddőségi kezelés eredményének elősegítése érdekében. Bizonyos körülmények és endometriózis kiterjedtség esetén a meddőségi kezelési alternatívák közül az inszemináció szintén ajánlott lehet, azonban súlyos stádiumban (rASRM III-IV.std), a petevezetékek roncsolódása esetén változatlanul a lombikbébi (IVF) eljárást alkalmazzuk pácienseinknél. Nagy segítséget jelentő, viszonylag új keletű, de tudományosan jól alátámasztott eszköz – az Endometriosis Fertility Index (EFI score) - került a kezünkbe, amely egy olyan pontozási rendszer, mely a műtéti kezelés során talált leletek figyelembevételével képez egy teherbe esési esély kalkulációt spontán terhesség és inszeminációs kezelési megoldás esetére. Ezen esélyt becslő módszer elősegíti a napi munkánk során az ideális tanácsadás lehetőségét.

Életmód és kiegészítő terápiák



dr. Brubel Réka
Szülész-nőgyógyász,
Egyetemi tanársegéd

Az alternatív és kiegészítő terápia hatékonysága klinikailag a mai napig nem bizonyított az endometriózis okozta fájdalom kezelésében. Az alternatív és kiegészítő terápia a következőket foglalja magában: a kismedencei beidegzésre ható neuromodulátorok, idegblokádok, TENS (Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation) segítséget nyújthatnak. Hasonlóképpen az akupunktúra, pszichoterápia, táplálékkiegészítők (vitaminok, ásványi anyagok), homeopátia, diéta, gyógynövények és a sport. Külföldi és hazai tapasztalat alapján azonban elmondható, hogy a gyógyszeres kezelésen kívül kiemelkedő fontosságú a megfelelő diéta és a rendszeres testmozgás. Éppen ezért az endometriózissal küzdőknek ajánljuk a cukrok, vörös húsok és a finomított szénhidrátok teljes elhagyását.

A vörös húsok rendelkeznek a legmagasabb arachidonsav-tartalommal, ami a szervezet egyik leghatásosabb gyulladáskeltő vegyülete. Így ezek teljes elhagyása az endometriózis okozta fájdalom csökkenését eredményezi. Javasolt endometriózisban jártas dietetikus, illetve táplálkozási szakértő felkeresése, akivel kialakítható egy, az adott állapothoz alkalmazkodó és annak megfelelő étrend.

Itt meg kell jegyeznünk, hogy tudományos bizonyítékok nem állnak rendelkezésre a kiegészítő terápiák hatékonyságával kapcsolatosan.

Ásványi anyagok és vitaminok tekintetében az endometriózis rizikója 24%-kal csökkent azoknál a nőknél, akik magasabb megjósolható D-vitamin-szinttel rendelkeznek. A fokozottabb napi kalcium- és magnéziumbevitel is csökkenti a betegség kialakulásának esélyét. Minden esetben érdemes ezt a tényt is

figyelembe venni az étrend kialakításakor és a táplálékkiegészítők kiválasztásakor. Heti minimum három alkalommal ajánlatos valamilyen aerob típusú edzésformát választani, például a kocogást, az úszást vagy a kerékpározást, és ezt alkalmanként minimum 30 perc időtartamban végezni. A mozgásformát minden esetben az egyéni állapothoz javasolt kiválasztani. Egyéb mozgásformák: jóga, Arwen-torna, Aviva-torna. A sport és a mozgás élettani hatásán kívül nem elhanyagolható az sem, hogy javítja a kedélyállapotot.

Az endometriózisban szenvedő nők nagy többsége ugyanis az állandó fájdalom, illetve a fájdalmas házasélet miatt sokszor párkapcsolati nehézségekről, valamint rossz közérzetről panaszkodik. Ajánlatos az endometriózis szakrendelésen pszichológus bevonásával is kiegészíteni a betegellátást. Az endometriózissal együtt járó lelki terhek megbeszélése csökkenti a szorongást és a betegségtudatot.







Táplálkozási tanácsok



Jándi-Kovács Krisztina
Gasztroenterológiai szakdietetikus

Az endometriózis tüneti terápiájának egyik hatékony segítője lehet a megfelelő táplálkozás. A diéta célja az ösztrogénszint, az oxidatív stressz és a gyulladás csökkentése. Az endometriózis és bizonyos étrendi változtatások kapcsán több pozitív végkimenetelű tanulmány is született, ahol az eredmények között szerepel a fájdalom és az endometrium sejtek méretének csökkenése, ezzel párhuzamosan pedig az életminőség javulása.

Az endometriózis diéta alapját képezik a friss zöldségek és gyümölcsök, amelyek lehetőleg minél kevesebb vagy még jobb ha teljesen vegyszermentes forrásból származnak. Bizonyos gyümölcsökben található polifenolok remek antioxidánsforrások, így ezeket érdemes napi szinten fogyasztani. A rezveratrol, ami az egyik legismertebb közülük, megtalálható például a szőlőmagban, ezáltal a szőlőmagból kinyert olajban is, valamint a bogyós gyümölcsökben (áfonya, málna, feketeribizli). A C vitamin szintén remek antioxidáns így a citrusfélék fogyasztása is rendkívül előnyös. A zöldségek közül a keresztesvirágúak (brokkoli, karfiol, káposzta stb.) puffasztó hatással bírhatnak, így ezek fogyasztása bélérintettség esetén az egyéni toleranciától függ.

A halak fogyasztása omega-3-zsírsav-tartalmuk miatt különösen ajánlott. A bennük található EPA és a DHA csökkentik a fájdalommal kapcsolatos tüneteket és a gyulladást, valamint a megelőzésben is szerepet játszanak. Amennyiben bármilyen indok miatt nem megoldható a rendszeres halfogyasztás, ajánlott az omega-3 bevitelt étrendkiegészítővel biztosítani. Amennyiben bármilyen indok miatt nem megoldható a heti legalább egy halfogyasztás, ajánlott az omega-3 bevitelt étrendkiegészítő segítségével biztosítani.

A húsok közül érdemes a sovány, fehér húsokat fogyasztani és a vörös húsok fogyasztását korlátozni.

A tejtermékekből is hasznosabb az alacsony zsírtartalmúakat választani és ha van lehetőség, azok közül is a bio termékeket emeljük le a polcról. A nagy mennyiségű vajfogyasztás növeli a betegség kockázatát.

A túl sok cukrot tartalmazó élelmiszerek (péksütemények, édességek, cukrozott italok) csak üres kalóriákat jelentenek, helyette tanácsosabb a rostban gazdag összetett szénhidrátokat előnyben részesíteni (búzakorpa, zöldségek, teljes kiőrlésű gabona termékek, hüvelyesek).

A feldolgozott ételeket érdemes redukálni és ezáltal minél kevesebb telített valamint transzzsírsavat fogyasztani. A zsírsavak összefüggésben állnak a szervezetben keletkező gyulladásokkal. A túlzott állati fehérje- és zsírfogyasztás felborítja a baktériumflórát. A palmitinsav, ami az állati zsiradékok és a pálmaolaj egyik fő összetevője pedig az ösztrogéntermelés fokozásában is részt vesz.

Bizonyos fűszerek szintén segíthetnek a gyulladáscsökkentésben, így ezeket érdemes az ételeink elkészítése során használni, mint például a kurkuma, a fahéj, a szerecsendió, a rozmaring, a gyömbér.

Összességében a magas zsír és a túlzott kalóriafogyasztás mindenképpen kerülendő, a mediterrán konyha és a japán ételek viszont jól illeszkednek az endometriózis diétába.

Fontos azonban megjegyezni, *hogy minden szervezetnek más a tápanyagigénye, ezért ajánlott dietetikus szakember felkeresése a személyre szabott étrend kapcsán.*

Endometriózis műtéti megoldásai

Mi az a laparoszkópia?



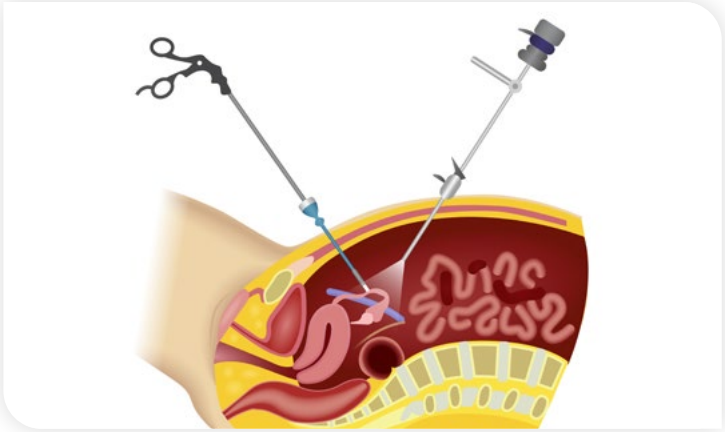
Dr. Csibi Noémi
szülés-nőgyógyász,
egyetemi tanársegéd

Endometriózis gyanúja esetén a leghatékonyabb diagnosztikai eszköz a műtét, mely során az összes látható elváltozás eltávolítására kerül a fájdalom kezelése és a teherbeesési esély növelése céljából. A beavatkozás történhet nyitott hason keresztül (laparotómia), illetve hastükrözéssel (laparoszkópia). Mindkét módszer hatásos lehet az endometriózis kezelésében, ugyanakkor jelenleg elsődlegesen a laparoszkópos megközelítés javasolt annak számos előnyös tulajdonsága miatt.

Laparoszkópia során a köldökön keresztül bevezetett vékony (1cm átmérőjű), kamerával összekapcsolt optikai rendszer által tekintjük át a kismedencét. A műtétek kezdeti lépése, hogy a hasüreget szén-dioxiddal töltjük fel a könnyebb áttekinthetőség és a műtétek elvégzéséhez szükséges mozgástér nyerése céljából. További 5, illetve 10 mm-es apró nyílásokat ejtünk (általában hármat-négyet), és az ezeken keresztül bevezetett finom műszerek segítségével végezzük el a műtétet.

A laparoszkópia előnyei:

- A kamera használata lehetővé teszi, hogy nagyított, részletgazdag képet lássunk, így az igen apró, szabad szemmel nem biztosan észlelhető elváltozások is felismerhetők.
- A kamera 360°-os mozgástere által a teljes hasüreg áttekinthető, így a has felső részén, a rekeszizmon és egyéb, ritkább előfordulási területeken is észlelhetőek és kezelhetőek az esetleges elváltozások.
- A has megnyitásával járó műtétek átlagosan 10-12 cm-es metszéssel járnak.



Forrás: https://pfmedicalcentre.com/js/tinymce/js/tinymce/plugins/filemanager/depot/Services/gynae-endo.jpg

Laparoszkópia során általában 3-4 apró (5-10mm-es) nyíláson keresztül elvégezhetőek a műtétek. A metszés mérete döntően befolyásolja a műtét utáni fájdalom mértékét: laparoszkópiát követően jelentősen kisebb fokú fájdalommal lehet számolni, mint nyitott hasi műtét után, illetve a kórházi tartózkodás ideje jelentősen rövidebb, a gyógyulási ütem pedig sokkal gyorsabb.

- A laparoszkópos műtéteket követően kevesebb összenövés kialakulásával kell számolnunk, mint hasmegnyitással járó műtéteket követően.
- A laparoszkópos behatolásból történt műtétek kedvezőbbek a teherbeesésre nézve, mint a nyitott hasi műtétek.
- A behatolások apró méretének köszönhetően sokkal szebb a kozmetikai eredmény, mint nyitott hasi műtétek esetén.

NOSE

A laparoszkópia során, amennyiben belet érintő mélyen infiltráló endometriózis igazolódott, és csak bélszakasz kimetszéssel kezelhető az elváltozás, az érintett bélszakasz eltávolítása a hasüregből több módon is történhet.



Dr. Dobó Noémi
Szülés-nőgyógyász, klinikai szakorvos

A klasszikus műtéti technika alkalmazása során az endometriózissal érintett bélszakaszt, a szeméremcsont felett elhelyezkedő 5 mm-es laparoszkópos hasmetszés meghosszabbításával segítségével nyert körülbelül 5 cm-es seben keresztül távolítjuk el.

A NOSE (Natural Orifice Specimen Extraction- Természeses testnyílásokon történő specimen eltávolítás) segítségével valamelyik természetes testnyílásokon keresztül történik a bélszakasz eltávolítása, így nem szükséges a hasi seb megnagyobbítása. Ilyen természetes testnyílás például a végbél, illetve a hüvely. A hüvelyen történő eltávolítást akkor alkalmazzuk, ha a mélyen



Forrás: Dobó N, Márki G, Hudelist G, Csibi N, Brubel R, Ács N, Bokor A. Laparoscopic natural orifice specimen extraction colectomy versus conventional laparoscopic colorectal resection in patients with rectal endometriosis: a randomized, controlled trial. Int J Surg. 2023 Dec 1;109(12):4018-4026.

infiltráló endometriózis a hüvelyfalat is érinti, így annak kimetszése a hüvelyfal megnyitásával j[illegible] érintett területek eltávolítása után az ép bélszakaszokat speciális bélvar[illegible]p segítségével egyeztetjük, illetve hüvelyfal megnyitás esetén a hüvely sebét is varratsorral zárjuk.

A NOSE technika számos előnnyel jár: a hasi metszés meghosszabbításának elkerülése segítségével kisebb a műtét utáni fájdalom, és a hasfali sérv képződésének az esélye. Műtét után gyorsabb a felépülés, rövidebb a kórházi tartózkodás, és nem utolsó sorban jobbak a kozmetikai eredmények.

A NOSE bélendometriózisban alkalmazott módosított technikáját a Semmelweis Egyetem Baross utcai Részlegén dolgozták ki és alkalmazták először belet érintő mélyen infiltráló endometriózis esetén.

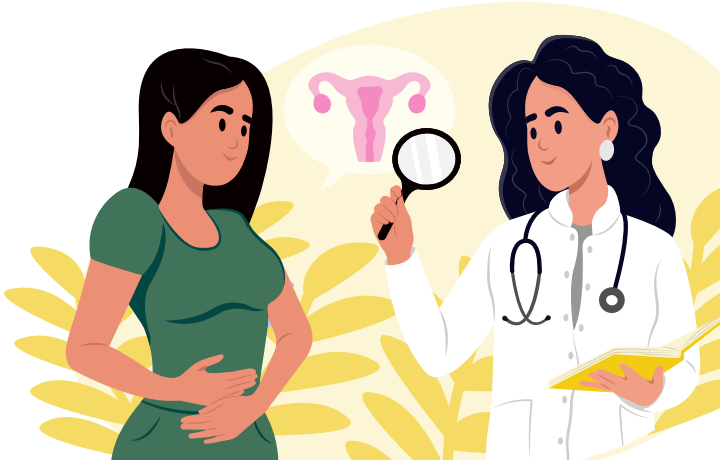
Orvos-páciens kommunikáció

A krónikus betegségekben szenvedők esetében különösen fontos az orvos-beteg bizalmi kapcsolata, igaz ez az endometriózisra is. Fontos, hogy mindig, minden esetben elmondjuk a tüneteinket, az aggályainkat, a kérdéseinket, hiszen a gyógyulásunk egy közös munka eredménye lesz, nem csak az orvoson múlik, sőt, nagy mértékben rajtunk áll és elősegíti, ha ez a kapcsolat bizalmas és őszinte.

Fontos, hogy bármilyen gyógyszeres vagy kiegészítő terápiát szeretnél kipróbálni, esetleg egy radikálisabb életmódváltásba kezdesz, azt az orvosoddal egyeztetve tedd, és szakértők bevonásával.

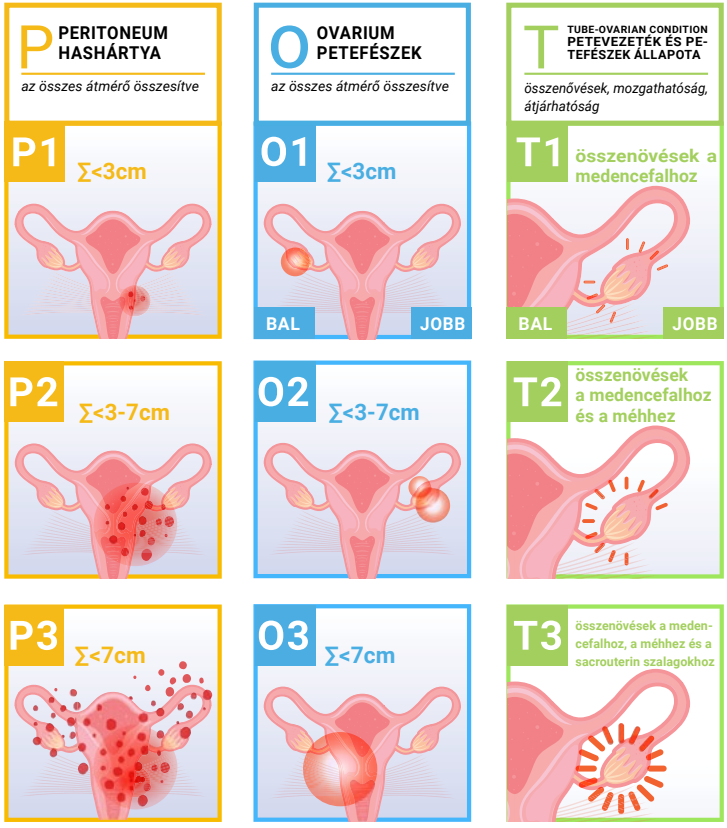
(pl. ha nem vagy dietetikus, ne kezdj el magadtól diétázni az internet alapján, hanem keress fel egy szakértőt!)

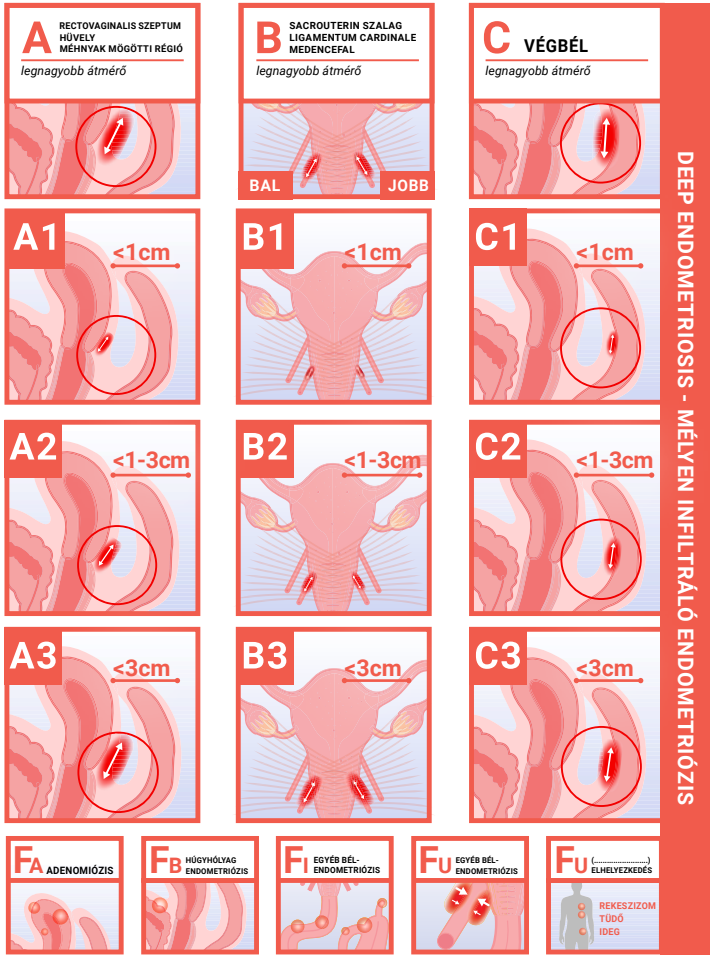
Kérdéseket feltenni sosem egyszerű, ebben segítségedre lehet ez a kiadvány is.



© Kecskeméti SEF

#ENZIAN
Az endometriózis osztályozása





Amikor bemegyünk az orvoshoz vizsgálatra, konzultációra, lányos zavarunkban, nem jutnak eszünkbe a kérdések, majd utána bosszankodunk, hogy mit felejtettünk el. Írd össze előre a kérdéseidet!

Műtéttel kapcsolatos kérdések

TIPP! - *A műtét előtt kérheted a Kórházi csomagot, amely segíti a műtétre való felkészülést és a kórházban töltött időszakra és a rehabilitációra is segítséget nyújthat.*

Műtét előtti időszakra vonatkozó kérdések

.....
.....
.....

Milyen vizsgálatok elvégzése szükséges a műtét előtt?

.....
.....
.....

Mennyivel korábban van szükség ezek elvégzésére és meddig használhatóak fel a leletek?

.....
.....
.....

Hogyan készüljek fel a műtétre? Mit végezzek el előtte otthon?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Műtéttel kapcsolatban

A műtét előtt hány nappal kell befeküdni a kórházba?

.....
.....
.....

Mit vigyek magammal a kórházba?

.....
.....
.....
.....

Egyéb kérdéseim:

.....
.....
.....
.....

Válaszok:

.....
.....
.....
.....

TIPP! - *Hogy megkönnyítsük a helyzeted, írunk néhány javaslatot is: fásli, pohár, kistányér, evőeszköz, szalvéta, szívószál, víz/tea/cukormentes üdítőital, tisztálkodási szerek, nedves törlőkendő, hálóing (nem pizsama!), hashajtó (a műtétet végző orvos által felírt), egészségügyi bugyi betéttel.*

Hogyan zajlik a betegfelvétel folyamata?

.....
.....
.....
.....

TIPP! - *Betegfelvételkor kell jelezni a speciális étrenddel kapcsolatos igényeket.*

Milyen előkészületekre számíthatok a műtét előtt?

Hányan és kik lesznek a műtőben?

Előreláthatólag meddig tart a műtét?

Milyen mellékhatásai lehetnek az altatásnak?

Egyéb kérdéseim:

Válaszok:

A kórházban tartózkodás ideje alatt

Mire számíthatok a műtét után? Milyen állapotban leszek, és hogyan fogom érezni magam?

Hány napig kell a kórházban tartózkodnom?

Egyéb kérdéseim:

Válaszok:

Műtét után

Mikor esedékes a varratszedés?

A kórház elhagyását követően melyek azok a tünetek, amelyek észlelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni? És melyek azok a tünetek, amelyek a természetes gyógyulás részei?

.....
.....
.....

Mikor történik a műtét utáni kezelési lehetőségek átbeszélése a kezelőorvossal?

.....
.....
.....

Milyen gyakran szükséges kontrollvizsgálat?

.....
.....
.....

Műtét után mennyi idővel lehet újra munkába állni?

.....
.....
.....

A műtét után mikor kezdhetek sportolni, aktívan mozogni? Milyen mozgást végezhetek?

.....
.....
.....

A műtét után hány héttel kezdhető el a nemi élet/gyermekvállalás?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Műtét után mennyi idővel kezdhető el inszemináció/lombik kezelés?

.....
.....
.....
.....

Műtét után milyen feladatokat végezhetek és mikortól? (pl. emelés, cipelés, bevásárlás)?

.....
.....
.....

Egyéb kérdéseim:

.....
.....
.....
.....

Válaszok:

.....
.....
.....
.....
.....

Gyermekvállalással kapcsolatos kérdéseim:

Endometriózis mellett teherbe tudok esni természetes úton?

.....
.....
.....
.....
.....

A gyermekvállalás segítheti az endometriózisból való gyógyulásomat?

Milyen lehetőségek vannak a teherbeesés segítésére orvosi úton?

Mi a számomra javasolt eljárás pontos folyamata?

Mesterséges megtermékenyítési eljárások esetén milyen hormonkezelés történik?

Milyen hatása, mellékhatása lehet a hormonkezelésnek?

Egyéb kérdéseim:

Válaszok:

Gyógyszeres kezeléssel kapcsolatos kérdéseim

Szükséges számomra a gyógyszeres kezelés? Milyen készítményt szükséges szednem és az hogyan hat a szervezetemre?

Meddig szedhetem a gyógyszert? Mi az adagolása?

Mik lehetnek a gyógyszer mellékhatásai?

Egyéb kérdéseim:

Válaszok:

Életmóddal kapcsolatos kérdéseim

Milyen étkezést kell folytatnom? Mire szükséges figyelnem?

Milyen mozgásforma javasolt számomra? Milyen gyakran kell mozognom?

Egyéb kérdéseim:

Válaszok:

További kérdések és válaszok

Kérdéseim:

Válaszok:

TIPP! - Ide feljegyezheted az orvosi vizsgálatok, kontrollok időpontjait.

Időpont	Helyszín	Kezelőorvos

Irodalomjegyzék

Irodalomlista - Dr. Bokor Attila

Keresztcsonti, obturátor, valamint ülőidegeket érintő endometriózis

Pain, gastrointestinal function and fertility outcomes of modified nerve-vessel sparing segmental and full thickness discoid resection for deep colorectal endometriosis - A prospective cohort study. Hudelist G, Pashkunova D, Darici E, Rath A, Mitrowitz J, Dauser B, Senft B, Bokor A. Acta Obstet Gynecol Scand. 2023 Oct;102(10):1347-1358.

Clinical and ultrasound characteristics of deep endometriosis affecting sacral plexus. Szabó G, Bokor A, Fancsovits V, Madár I, Darici E, Pashkunova D, Arányi Z, Fintha A, Rigó JJ, Lipták L, Mázsár B, Hudelist G. Ultrasound Obstet Gynecol. 2024 Feb 5

Diagnostic accuracy of the IDEA protocol for non invasive diagnosis of rectosigmoid DE - a prospective cohort study. Szabó G, Hudelist G, Madár I, Rigó JJ, Dobó N, Fintha A, Lipták L, Kalovics E, Fancsovits V, Bokor A. Ultraschall Med. 2024 Feb;45(1):61-68. doi: 10.1055/a-2034-2022. Epub 2023 Feb 13.

Comparison of #Enzian classification and revised American Society for Reproductive Medicine stages for the description of disease extent in women with deep endometriosis.Montanari E, Bokor A, Szabó G, Kondo W, Trippia CH, Malzoni M, Di Giovanni A, Tinneberg HR, Oberstein A, Rocha RM, Leonardi M, Condous G, Alsalem H, Keckstein J, Hudelist G.Hum Reprod. 2022 Sep 30;37(10):2359-2365

ESHRE guideline: endometriosis. Becker CM, Bokor A, Heikinheimo O, Horne A, Jansen F, Kiesel L, King K, Kvaskoff M, Nap A, Petersen K, Saridogan E, Tomassetti C, van Hanegem N, Vulliemoz N, Vermeulen N; ESHRE Endometriosis Guideline Group. Hum Reprod Open. 2022 Feb 26;2022(2) The #Enzian classification: A comprehensive non-invasive and surgical description system for endometriosis.

Keckstein J, Saridogan E, Ulrich UA, Sillem M, Oppelt P, Schweppe KW, Krentel H, Janschek E, Exacoustos C, Malzoni M, Mueller M, Roman H, Condous G, Forman A, Jansen FW, Bokor A, Simedrea V, Hudelist G. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021 Jul;100(7):1165-1175

Surgical outcomes of women undergoing radical resection of deep endometriosis of the sacral plexus: A prospective cohort study. Hudelist G, Darici Kurt E, Szabó G, Miklos D, Hudelist T, Bokor A.Acta Obstet Gynecol Scand. 2025 Jan;104(1):95-101. doi: 10.1111/aogs.15015. Epub 2024 Nov 29

Adenomiózis

Rees C, van Vliet H, Siebers A, Bulten J, Huppelschoten A, Westerhuis M, Mischi M, Schoot B.

The ADENO study: ADenomyosis and its Effect on Neonatal and Obstetric outcomes: a retrospective population-based study. Am J Obstet Gynecol. 2022 Dec 17:S0002-9378(22)02291-8.
Alcázar JL, Vara J, Usandizaga C, Ajossa S, Pascual MÁ, Guerriero S. Transvaginal ultrasound versus magnetic resonance imaging for diagnosing adenomyosis: A systematic review andhead-to-head meta-analysis. Int J Gynaecol Obstet. 2022 Dec 3.

Lazzeri L, Morosetti G, Centini G, Monti G, Zupi E, Piccione E, Exacoustos C. A sonographic classification of adenomyosis: interobserver reproducibility in the evaluation of type and degree of the myometrial involvement. Fertil Steril. 2018 Nov;110(6):1154-1161.e3.

Chapron C, Vannuccini S, Santulli P, Abrão MS, Carmona F, Fraser IS, Gordts S, Guo SW, Just PA, Noël JC, Pistofidis G, Van den Bosch T, Petraglia F. Diagnosing adenomyosis: an integrated clinical and imaging approach. Hum Reprod Update. 2020 Apr 15;26(3):392-411.

Irodalomlista – Brubel Réka

Giudice LC, Kao LC. Endometriosis. Lancet. 2004 Nov 13-19; 364 (9447):1789-99.

Meuleman C, D'Hoore A, Van Cleynenbreugel B, Beks N, D'Hooghe T. Outcome after multidisciplinary CO2 laser laparoscopic excision of deep infiltrating colorectal endometriosis. Reprod Biomed Online. 2009 Feb;18(2):282-9.

Attia GR, Zeitoun K, Edwards D, Johns A, Carr BR, Bulun SE. Progesterone receptor isoform A but not B is expressed in endometriosis. J Clin Endocrinol Metab. 2000 Aug;85(8):2897-902.

Schweppe KW. Guidelines for the use of GnRH-analogues in the treatment of endometriosis.Zentralbl Gynakol. 2005 Oct;127:308-13. [Article in German]

Marana R, Muzii L, Muscatello P, Lanzone A, Caruso A, Dell'Acqua S, Mancuso S. Gonadotrophin releasing hormone agonist (buserelin) in the treatment of endometriosis: changes in the extent of the disease and in CA 125 serum levels after 6-month therapy. Br J Obstet Gynaecol. 1990 ;97:1016-9.

Sallam HN, Garcia-Velasco JA, Dias S, Arici A. Long-term pituitary down-regulation before in vitro fertilization (IVF) for women with endometriosis. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jan 25:CD004635.
Canis M. Indications of GnRH analogues before and after surgery for endometriosis. Gynecol Obstet Fertil 2005;33:1014-7. [Article in French]

Abou-Setta AM, Houston B, Al-Inany HG, Farquhar C. Levonorgestrel-releasing intrauterine device (LNG-IUD) for symptomatic endometriosis following surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jan 31;1:CD005072. doi: 10.1002/14651858.CD005072.pub3. Review.

Vercellini P, Frontino G, De Giorgi O, Aimi G, Zaina B, Crosignani PG. Comparison of a

levonorgestrel-releasing intrauterine device versus expectant management after conservative surgery for symptomatic endometriosis: a pilot study. Fertil Steril. 2003 Aug;80(2):305-9.

Chapron C, Souza C, Borghese B, Lafay-Pillet MC, Santulli P, Bijaoui G, Goffinet F and de Ziegler D. Oral contraceptives and endometriosis: the past use of oral contraceptives for treating severe primary dysmenorrhea is associated with endometriosis, especially deep infiltrating endometriosis. Hum Reprod 2011; 26:2028–2035.

McGettigan P, Henry D. Use of non-steroidal anti-inflammatory drugs that elevate cardiovascular risk: an examination of sales and essential medicines lists in low-, middle-, and high-income countries. PLoS Med. 2013;10:e1001388.

Allen C, Hopewell S, Prentice A and Gregory D. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for pain in women with endometriosis. Cochrane Database Syst Rev 2009:CD004753.

Mäkäräinen L, Rönnberg L and Kauppila A. Medroxyprogesterone acetate supplementation diminishes the hypoestrogenic side effects of gonadotropin-releasing hormone agonist without changing its efficacy in endometriosis. Fertil Steril 1996; 65:29–34.

Moghissi KS, Schlaff WD, Olive DL, Skinner MA and Yin H. Goserelin acetate (Zoladex) with or without hormone replacement therapy for the treatment of endometriosis. Fertil Steril 1998; 69:1056–1062.

Somigliana E, Vercellini P, Vigano' P, Benaglia L, Busnelli A, Fedele L. Postoperative medical therapy after surgical treatment of endometriosis: from adjuvant therapy to tertiary prevention. J Minim Invasive Gynecol. 2013; S1553-4650(13)01297-1.

Vercellini P, Viganò P, Somigliana E, Fedele L. Endometriosis: pathogenesis and treatment. Nat Rev Endocrinol. 2013 doi: 10.1038/nrendo.2013.255.

Nasu K, Kawano Y, Tsukamoto Y, Takano M, Takai N, Li H, Furukawa Y, Abe W, Moriyama M, Narahara H. Aberrant DNA methylation status of endometriosis: epigenetics as the pathogenesis, biomarker and therapeutic target. J Obstet Gynaecol Res. 2011 37:683-95. Guo SW. Epigenetics of endometriosis. Mol Hum Reprod. 2009 15:587-607.

Vercellini P, Frontino G, De Giorgi O, Pietropaolo G, Pasin R and Crosignani PG. Continuous use of an oral contraceptive for endometriosis-associated recurrent dysmenorrhea that does not respond to a cyclic pill regimen. Fertil Steril 2003; 80:560–563.

Crosignani P, Olive D, Bergqvist A, Luciano A. Advances in the management of endometriosis: an update for clinicians. Hum Reprod Update. 2006;122:179-89.

Vercellini P, Barbara G, Somigliana E, Bianchi S, Abbiati A and Fedele L. Comparison of contraceptive ring and patch for the treatment of symptomatic endometriosis. Fertil Steril 2010; 93:2150–2161.

Farquhar C, Prentice A, Singla AA, Selak V. Danazol for pelvic pain associated with endometriosis. Cochrane Database Syst Rev 2007; 4: CD000068.
Brown J, Kives S and Akhtar M. Progestagens and anti-progestagens for pain associated with endometriosis. Cochrane Cochrane Database Syst Rev 2012; 3:CD002122.
Adolf E Schindler. Dienogest in long-term treatment of endometriosis. Int J Womens Health. 2011; 3: 175–184. 2011: 10.2147/IJWH.S5633

Strowitzki T, Marr J, Gerlinger C, Faustmann T, Seitz C. Dienogest is as effective as leuprolide acetate in treating the painful symptoms of endometriosis: a 24-week, randomized, multicentre, open-label trial. Hum Reprod. 2010;25:633–641.

McCormack PL. Dienogest: a review of its use in the treatment of endometriosis. Drugs. 2010 Nov 12;70:2073-88.

Ferrero S, Gillott DJ, Venturini PL and Remorgida V. Use of aromatase inhibitors to treat endometriosis-related pain symptoms: a systematic review. Reprod Biol Endocrinol 2011; 9:89.

Nawathe A, Patwardhan S, Yates D, Harrison GR and Khan KS. Systematic review of the effects of aromatase inhibitors on pain associated with endometriosis. BJOG 2008; 115:818–822.

Warnock JK, Bundren JC, Morris DW. Depressive mood symptoms associated with ovarian suppression. Fertil Steril. 2000;74:984-6.

Astin JA, Marie A, Pelletier KR, Hansen E and Haskell WL. A review of the incorporation of complementary and alternative medicine by mainstream physicians. Arch Intern Med 1998; 158:2303–2310.
Flower A, Liu JP, Chen S, Lewith G and Little P. Chinese herbal medicine for endometriosis. Cochrane Database Syst Rev 2009:CD006568.

Parazzini F1, Chiaffarino F, Surace M, Chatenoud L, Cipriani S, Chiantera V, Benzi G, Fedele L. Selected food intake and risk of endometriosis. Hum Reprod. 2004 Aug;19(8):1755-9.

Mathias JR, Franklin R, Quast DC, Fraga N, Loftin CA, Yates L, Harrison V. Relation of endometriosis and neuromuscular disease of the gastrointestinal tract: new insights. Fertil Steril. 1998 Jul;70(1):81-8.

Koppan A, Hamori J, Vranics I, Garai J, Kriszbacher I, Bodis J, Rebek-Nagy G, Koppan M. Pelvic pain in endometriosis: painkillers or sport to alleviate symptoms? Acta Physiol Hung. 2010 Jun;97(2):234-9. doi: 10.1556/APhysiol.97.2010.2.10.

Committee on Adolescent Health Care Long-Acting Reversible Contraception Working Group. Adolescents an Long-Acting Reversible Contraception: Implants and Intrauterine Devices. Number .539, 2012

Harris HR, Chavarro JE, Malspeis S, Willett WC, Missmer SA. Dairy-food, calcium, magnesium, and vitamin D intake and endometriosis: a prospective cohort study. Am J Epidemiol. 2013 Mar 1;177:420-30.

Irodalomlista - Dr. Csibi Noémi

MI AZ A LAPAROSZKÓPIA?

Becker CM, Bokor A, Heikinheimo O, Horne A, Jansen F, Kiesel L, King K, Kvaskoff M, Nap A,Petersen K, Saridogan E, Tomassetti C, van Hanegem N, Vulliemoz N, Vermeulen N; ESHRE Endometriosis Guideline Group. ESHRE guideline: endometriosis. Hum Reprod Open. 2022 Feb 26;2022(2):hoac009. doi: 10.1093/hropen/hoac009. PMID: 35350465; PMCID: PMC8951218.

Bellelis P, Podgaec S, Abrao MS. (2011) Environmental factors and endometriosis. Rev Assoc Med Bras (1992), 57(4): 448-452.

Burney RO, Giudice LC. (2012) Pathogenesis and pathophysiology of endometriosis. Fertil Steril, 98(3): 511-519.

Hudelist, G., et al., Diagnostic delay for endometriosis in Austria and Germany: causes and possible consequences. Hum Reprod, 2012. 27(12): p. 3412-6.

Lee, H.J., et al., Various anatomic locations of surgically proven endometriosis: A single-center experience. Obstet Gynecol Sci, 2015. 58(1): p. 53-8. Rocha AL, Reis FM, Petraglia F. (2012) New trends for the medical treatment of endometriosis. Expert Opin Investig Drugs, 21(7): 905-919.

Vercellini P, Trespidi L, Giorgi OD, Cortesi I, Parazzini F, Crosignani PG. (1996)Endometriosis and pelvic pain: relation to disease stage and localization. Fertil Steril, 65(2):299-304.

NOSE:

Bokor A, Hudelist G, Dobó N, Dauser B, Farella M, Brubel R, et al. Low anterior resection syndrome following different surgical approaches for low rectal endometriosis: A retrospective multicenter study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021;100(5):860-7.

Laparoscopic natural orifice specimen extraction colectomy versus conventional laparoscopic colorectal resection in patients with rectal endometriosis: a randomized, controlled trial.
Dobó N, Márki G, Hudelist G, Csibi N, Brubel R, Ács N, Bokor A.
Int J Surg. 2023 Dec 1;109(12):4018-4026

Bokor A, Lukovich P, Csibi N, D'Hooghe T, Lebovic D, Brubel R, Rigo J. Natural Orifice Specimen Extraction during Laparoscopic Bowel Resection for Colorectal Endometriosis: Technique and Outcome. J Minim Invasive Gynecol. 2018 Sep-Oct;25(6):1065-1074. doi:10.1016/j.jmig.2018.02.006.

Bokor A, Pohl A, Lukovich P, Rigó J Jr. Műtéti preparátum eltávolítása a hüvelyen keresztül a vastagbelet érintő mélyen infiltráló endometriosis laparoszkópos műtéte során

[Transvaginal specimen extraction after laparoscopic bowel resection in deeply infiltrating endometriosis]. Orv Hetil. 2014 Mar 16;155(11):420-3. Hungarian. doi: 10.1556/OH.2014.29841.

Lukovich P, Rigó J, Harsányi L, Bokor A. Belet infiltráló endometriózis ellátásának sebészi szempontjai 120 eset kapcsán. Magy Seb. 2015 Oct;68(5):197-203. Hungarian. doi: 10.1556/1046.68.2015.5.2.

Lukovich P, Bokor A. A laparoszkópos sebészet invazivitásának csökkentése természetes szájadékok és hasfali defektusok felhasználásával a műtéti specimen eltávolítására [Reducing invasiveness of laparoscopic surgery using natural orifices and abdominal wall defects for extraction of the specimen]. Orv Hetil. 2015 Apr 5;156(14):552-7. Hungarian. doi: 10.1556/OH.2015.30116.

Lukovich P, Csibi N, Bokor A. A transrectalis specimeneltávolítás sebésztechnikai kérdései [Technical questions of the transrectal specimen extraction]. Magy Seb. 2016 Mar;69(1):20-6. Hungarian. doi: 10.1556/1046.69.2016.1.4.

Miklós D, Dobó N, Csibi N, Brubel R, Szabó G, Ács N, Bokor A. Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis laparoszkópos kezelésével szerzett tízéves tapasztalataink [Laparoscopic treatment of deeply infiltrating colorectal endometriosis - ten years of single center experience]. Orv Hetil. 2023 Mar 5;164(9):348-354. Hungarian. doi: 10.1556/650.2023.32714.

Lucy menstruációs és termékenységi naptár, ami figyel az egészségedre is.

Töltsd le a Lucy app-ot!

7 féle betegség kockázatára figyelünk, a Lucyban egy szakorvosi ellenőrzés mellett fejlesztett algoritmus ellenőrzi, hogy a felvitt tünetek alapján érdemes-e felkeresni a nőgyógyászt. Az algoritmus arra is figyel, hogy probléma esetén milyen betegségek előfordulására érdemes kiemelten figyelni. A betegségek közül a következők tüneteit ismeri fel az alkalmazás:

- endometriózis
- PCOS
- mióma
- petefészek ciszta
- kismedencei gyulladás
- cukorbetegség
- IR



Miben segít még?

Lucy összegyűjti a legfontosabb információkat a bejegyzésekből, és készít egy összegzést, amit ha megmutatunk az orvosunknak, akkor sokkal pontosabb képet kaphat az egészségügyi állapotunkról, és így jobb kezelést kaphatunk, amennyiben szükséges. A rendszeresen vezetett tünetek nagy segítséget jelenthetnek a pontos diagnózis felállításában.

Töltsd le az app-ot:

https://hellolucy.app

Facebook

Betekintést nyerhetsz az alapítvány életébe és követheted az aktuális eseményeket.

Facebook Szakértői Csoport

Csatlakozz az Endometriózis Szakértői Csoportba, ahol érintettek osztják meg egymással tapasztalataikat és szakemberek tartanak élő bejelentkezéseket. Endometriózisban érintettek és családtagjaik is jelentkezhetnek.

Podcast

Az eddigi előadásaink, beszélgetéseink értékes tudásanyagát és új témákat is feldolgozunk a podcastjainkban.

Keresd az Endometriózis Magyarország oldalát!

Youtube

Szakértőinkkel készült előadások, beszélgetések itt érhetőek el.

Iratkozz fel!

LinkedIn

Ismerd meg az alapítvány projektjeit, nemzetközi tevékenységét.

Instagram

Ismerd meg az endometriózissal kapcsolatos tényeket és tévhiteket.

Kérjük támogass adód 1%-val!



1%
Ne hagyd veszni

“Együtt könnyebb”
Női Egészségért Alapítvány

Adószámunk: 18628175-1-43

Segíts, hogy sorstársaink időben kapjanak diagnózist!

Köszönjük támogatóinknak, hogy segítették a könyv megszületését.

- Andrológia
- Általános nőgyógyászat
- Belgyógyászat
- Diabetológia
- Endokrinológia
- Endometriózis ellátás
- Hematológia
- Labordiagnosztika
- Nőgyógyászat
- Pszichológia
- Radiológia
- Reproduktív sebészet
- Szülészet
- Terhesgondozás
- Ultrahangdiagnosztika

MEDEND MEDDŐSÉGI ÉS ENDOMETRIÓZIS INTÉZET

PROFESSZIONÁLIS ENDOMETRIÓZIS ÉS REPRODUKTÍV ELLÁTÁS

Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezünk és évente több, mint 1000 nőgyógyászati műtétet végzünk.

A MedEnd Meddőségi és Endometriózis Intézet létrehozásakor célunk az volt, hogy a női-férfi egészség és termékenység ellátását egy helyen, azonos felfogásban, a legkorszerűbb műszereket és tudományos eredményeket felhasználva tudjuk elvégezni.



időpontfoglalás

+36-1-919-0110
www.medend.hu

1027 Budapest
Varsányi Irén utca 21.

TritonLife MAGÁNKÓRHÁZ

A TritonLife Magánkórház elkötelezett a női megbetegedések mielőbbi felismerése és kezelése mellett. Endoszkópos Centrumunk lehetővé teszi, hogy **az endometriózis kezelését a lehető legmagasabb minőségben** végezhessük. Szakembereink több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek a betegség diagnosztizálása és operációja tekintetében.

A TritonLife endometriózis ellátása a páciensek egyéni igényeire összpontosít. Szoros együttműködésben dolgozunk a betegekkel, hogy mindenki számára a legmegfelelőbb kezelési tervet dolgozzuk ki. Célunk, hogy a páciensek életminősége javuljon, és a betegség által okozott kellemetlenségek csökkenjenek.

Szakembereink



Dr. Nyéky Boldizsár
szülész-nőgyógyász, endometriózis specialista



Dr. Fülöp István
szülész-nőgyógyász, endometriózis specialista, Endoszkópos Centrumvezető



Dr. Tekse István
szülész-nőgyógyász, endometriózis specialista

Elérhetőség:

+36 70 659 8888
www.tritonlife.hu
kapcsolat@tritonlife.hu

Tanácsadás

Együttműködésben állunk pszichológusokkal és dietetikusokkal is, hogy a betegeink teljes körű támogatást kapjanak. A pszichológiai támogatás segít a betegeknek megbirkózni a betegség okozta stresszel és érzelmi kihívásokkal, míg a dietetikusok speciális étrendi tanácsokkal látják el őket a tünetek enyhítése érdekében.

www.endometriozismagyarorszag.hu

A javasolt szakértők és endometriózis centrumok listáját megtalálhatod a weboldalon.

Együttműködő partnerek, támogatók:

BELÜGYMINISZTÉRIUM

MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA 1989

PAUKER® az én nyomdám